UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Dermatologie
Facteurs de risque et prise en charge du mélanome.
avec patient
sans geste clinique

Noms des rédacteurs : Kelili Céleste ; Vedelago Tom **Date de rédaction : 03/01/2024**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 327 – Annonce d'un diagnostic de maladie grave au patient et/ou à sa famille

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : (Entretien/interrogatoire)

Domaine de compétence n°2 (en sélectionner 1 SEUL) : (Annonce)

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1-

2-

Patient simulé nécessaire à la station : OUI (Patient 60/70 ans)

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- Feuille d'anatomopathologie d'exérese du mélanome

- Bureau de consultation

-

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synospis : (décrivez en quelques lignes ici le résumé du rôle et précisez s'il y a un contact physique ou non)

Vous avez 65 ans vous êtes jardinier à la retraite. Vous avez rendez-vous chez votre médecin généraliste suite à un diagnostic récent de mélanome du bras gauche, vous n'avez pas bien compris ce que votre dermatologue vous a expliqué.
Un étudiant en médecine va vous expliquer votre diagnostic, vous interroger sur vos facteurs de risques de mélanome et répondre à vos questions.
L'étudiant ne doit pas vous examiner.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : Lambert Prénom : Jacques Age : 65 profession : Jardinier retraité situation maritale : mariée 2 enfants lieu de vie : Nice en maison Phototype : roux qui ne bronze pas au soleil (prend uniquement des coups de soleil)
Antécédents	(*utiliser des mots simples et limiter aux antécédents pertinents sauf si distracteur utile)* *Mère et sœur ont eu un mélanome*
Médicaments actuels/ Toxiques	*Aucun*
Etats d'esprit/ comportement	Posture assise Douleur : pas de douleur Angoisse : forte Colère : pas de colère
Déroulement du scénario	Vous êtes assis. Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : ***"Je viens vous voir car j'ai vu mon dermatologue la semaine dernière qui m'a dit que le grain de beauté sur mon bras était malade, on me l'a retiré dans la foulée mais je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait. Je viens vous voir pour que vous puissiez un peu plus m'expliquer "***

	Tendez le document d'anatomopathologie à l'étudiant. L'étudiant doit normalement vous expliquer que vous avez un mélanome qui est un cancer de la peau. Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement.
Autres questions à poser au médecin, à quel moment	Quand l'étudiant vous demande si vous avez une question (après vous avoir demandé vos facteurs de risque) : « Le dermatologue m'a parlé d'une technique de ganglion sentinelle je crois mais je n'ai pas bien compris en quoi ça consiste pouvez-vous m'expliquer ? »

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Est-ce que vous avez eu beaucoup de coups de soleil dans l'enfance ?	Oui à mon époque on n'utilisait pas beaucoup de crème solaire
Est-ce que vous avez la peau claire/ est-ce que vous bronzez bien au soleil ?	Je suis roux, je ne bronze jamais je prends toujours des coups de soleil.
Avez-vous dans votre famille des gens qui ont eu des cancers de la peau/melanomes ?	Oui ma mère et ma sœur ont eu des mélanomes
Avez-vous déjà eu un mélanome ou un cancer de la peau ?	Non jamais
Avez-vous plus de 50 grains de beauté de grande taille ?	Non je n'en ai pas autant
Quel était votre métier ?	J'étais jardinier

Instructions à l'étudiant

Vous êtes médecin généraliste en cabinet.

Vous recevez M. Lambert en consultation suite à son rendez-vous chez le dermatologue. Il vous présente ses résultats d'exérèse d'une lésion pigmentée du bras gauche.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Expliquer au patient son diagnostic en vous aidant du document fourni par le patient.
2. Rechercher les facteurs de risque de mélanome chez ce patient.
3. Répondez à la question du patient.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Écoute le motif de consultation du patient sans l'interrompre	
Énonce le diagnostic de cancer	
Énonce les facteurs pronostics retrouvé au bilan d'anatomo-pathologie	
Tache 2	
Demande les antécédents familiaux de cancer	
Demande les antécédents personnels de mélanome	
Demande le phototype	
Demande si le patient a subi de nombreux coups de soleil dans l'enfance	
Recherche le métier du patient	
Demande si le patient a de nombreux naevi	
Tache 3	
Explique ce qu'est un ganglion sentinelle	
Explique la technique permettant de le détecter	
Explique l'intérêt de le retirer	
COMPETENCES GENERIQUES	
L'étudiant salue le patient de manière appropriée, se présente et vérifie l'identité du patient.	1 à 5
L'entretien suit un enchainement logique et donne au patient la possibilité de raconter son histoire.	
La prise en charge du patient est claire et les explications sont d'un niveau de compréhension appropriées.	

UTILISER IMPERATIVEMENT DES VERBES d'ACTION ex : « Dit » « Énonce » « Palpe » « Écoute »
SEPARER CHAQUE ITEM (ex : « recherche une consommation de tabac » et « quantifie une consommation de tabac » sont deux items différents)

MAXIMUM 15 Items de compétence spécifiques et 5 items de compétences génériques
Choisir les plus pertinents/discriminants

Fournir des schémas pour les points cliniques à évaluer par l'examinateur (cadrans d'examen abdominal, foyers d'auscultation etc.)

Préciser quand l'examinateur doit intervenir pour donner un signe clinique positif

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Écoute le motif de consultation du patient sans l'interrompre	1
Énonce le diagnostic de cancer	1
Énonce les facteurs pronostics retrouvé au bilan d'anatomo-pathologie	1
Tache 2	
Demande les antécédents familiaux de cancer	1
Demande les antécédents personnels de mélanome	1
Demande le phototype	1
Demande si le patient a subi de nombreux coups de soleil dans l'enfance	1
Recherche le métier du patient	1
Demande si le patient a de nombreux naevi	1
Tache 3	
Explique ce qu'est un ganglion sentinelle	1
Explique la technique permettant de le détecter	1
Explique l'intérêt de le retirer	1
COMPETENCES GENERIQUES	
L'étudiant salue le patient de manière appropriée, se présente et vérifie l'identité du patient.	Échelle de 1 à 5
L'entretien suit un enchainement logique et donne au patient la possibilité de raconter son histoire.	
La prise en charge du patient est claire et les explications sont d'un niveau de compréhension appropriées.	

DOCUMENT À FOURNIR À L'ÉTUDIANT

Anatomopathologie :

EXÉRÈSE D'UNE LÉSION CUTANÉE DU BRAS GAUCHE

Taille du fragment cutané : 22 x 20 mm Taille de la lésion macroscopique : 15 mm

Lésion pigmentée cutanée d'apparition récente à croissance rapide.

Diagnostic : Mélanome SSM

Caractère primitif du mélanome : oui

Épaisseur selon Breslow : 1,5 mm

Ulcération : oui

Activité mitotique : < 1/mm2

Exérèse complète : oui. Les limites d'exerese sont saines, avec une marge minimale en profondeur et latérale de 3mm